·临床研究·

综合医院躯体症状障碍患者的生活质量及其影响因素分析

吴珩[1]　李涛[2]　陈亦笑[1]　马希权[3]　张岚[4]　张耀尹[5]　陈华[6]　李闻天[7]　任洁[8]
卢伟[9]　魏镜[2]　Kurt Fritzsche[10]

[1]同济大学附属同济医院心身医学科，上海 200065；[2]中国医学科学院北京协和医院心理医学科 100730；[3]同济大学附属东方医院心身医学科，上海 210012；[4]四川大学华西医院心理卫生中心，成都 610041；[5]电子科技大学附属四川省人民医院心身医学科，成都 610072；[6]复旦大学附属中山医院心理医学科，上海 200032；[7]武汉精神卫生中心临床心理科 430012；[8]山西晋城无烟煤矿业集团有限公司总医院康复科 048006；[9]首都医科大学附属北京中医医院心身医学科 100010；[10]德国弗莱堡大学医学中心心身医学及心理治疗科，弗莱堡 79104

通信作者：魏镜，Email：weijing@pumch.cn

【摘要】　目的　探讨躯体症状障碍（somatic symptom disorder，SSD）患者的生活质量及其影响因素。**方法**　采取方便取样法，于 2016 年 5 月至 2018 年 1 月在北京、上海、成都、武汉、晋城的 9 家三级综合医院的门诊连续纳入患者，经结构化访谈纳入 SSD 患者 236 例，采集患者的人口学资料、生活方式及就诊行为、治疗满意度和主观治疗效果等信息，采用 12 项健康调查简表（12-item medical outcomes study short form health survey，SF-12）、患者健康问卷躯体症状群量表（Patient Health Questionnaire-15，PHQ-15）、躯体症状障碍诊断 B 标准量表（Somatic Symptom Disorder-B Criteria Scale，SSD-12）评估生活质量、躯体症状严重程度以及对躯体症状的认知、感受和行为，并根据 SSD-12 评分将患者分为高分组（SSD-12≥16 分，n=56）和低分组（SSD-12>16 分，n=180），2 组间计量资料比较采用 t 检验、Mann-Whitney U 检验，计数资料比较采用卡方检验，采用 Pearson 相关、多重线性回归分析 SSD 患者生活质量的影响因素。**结果**　与低分组比较，高分组患者担忧躯体不适时间更长［1.0（0.5，2.0）h/d 与 3.0（1.0，8.0）h/d，Z=−5.928，P<0.01］、治疗满意度更差［（3.4±1.4）分与（2.2±1.8）分，t=4.073，P<0.01］、主观治疗效果更差［（3.3±1.4）分与（2.2±1.5）分，t=4.353，P<0.01］，躯体及心理负担更重，生活质量更低；Pearson 相关分析显示，SSD 患者的生活质量与抑郁症状严重程度（r=−0.662，P<0.01）、症状相关的认知行为（r=−0.603，P<0.01）呈强相关，与躯体症状数量和严重程度（r=−0.477，P<0.01）呈弱相关。多重线性回归分析显示，抑郁症状严重程度、与症状相关的认知行为对 SSD 患者的生活质量有显著影响，可解释生活质量 61.7% 的变异（调整后 R^2=0.580，P<0.05）。**结论**　SSD 患者的抑郁症状严重程度及对躯体症状的认知、感受和行为是其生活质量受损的重要影响因素，应引起重视并积极干预。

【关键词】　躯体型障碍；　躯体症状障碍；　生活质量

Quality of life and the influencing factors in patients with somatic symptom disorders in general hospital

Wu Heng[1], Li Tao[2], Chen Yixiao[1], Ma Xiquan[3], Zhang Lan[4], Zhang Yaoyin[5], Chen Hua[6], Li Wentian[7], Ren Jie[8], Lu Wei[9], Wei Jing[2], Kurt Fritzsche[10]

DOI：10.3760/cma.j.issn.113661-20200827-00377

收稿日期　2020-08-27　　**本文编辑**　高蓓蕾

引用本文：吴珩，李涛，陈亦笑，等. 综合医院躯体症状障碍患者的生活质量及其影响因素分析[J]. 中华精神科杂志，2021，54(3)：190-196. DOI：10.3760/cma.j.issn.113661-20200827-00377.

[1]Department of Psychosomatic Medicine, Tongji Hospital, School of Medicine, Tongji University, Shanghai 200065, China; [2]Department of Psychological Medicine, Peking Union Medical College Hospital, Chinese Academy of Medical Sciences Beijing 100730, China; [3]Department of Psychosomatic Medicine, Dongfang Hospital, School of Medicine, Tongji University, Shanghai 210012, China; [4]Mental Health Center, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu 610041, China; [5]Department of Psychosomatic Medicine, Sichuan Provincial People's Hospital, University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu 610072, China; [6]Department of Psychological Medicine, Zhongshan Hospital, Fudan University, Shanghai 200032, China; [7]Department of Clinic Psychology, Wuhan Mental Health Center, Wuhan 430012, China; [8]Department of Rehabilitation, General Hospital of Jincheng Anthracite Coal Mining Group Co. Ltd, Jincheng 048006, China; [9]Department of Psychosomatic Medicine, Beijing Hospital of Traditional Chinese Medicine, Capital Medical University, Beijing 100010, China; [10]Department of Psychosomatic Medicine and Psychotherapy, Freiburg University Medical Center, Freiburg 79104, Germany

Corresponding author: Wei Jing, Email: weijing@pumch.cn

【**Abstract**】 **Objective** To explore the quality of life and its influencing factors in patients with somatic symptom disorder (SSD). **Methods** Patients were recruited from the outpatient departments of cardiology, neurology, gastroenterology, traditional Chinese medicine and psychiatry. SSD patients were included through structured interviews. Demographic data, lifestyle and medical treatment behavior, treatment satisfaction and subjective treatment effect were collected. Participant's quality of life, severity of somatic symptoms, and thoughts, feelings, and behaviors associated to the somatic symptoms were evaluated by the 12-item medical outcomes study short form health survey (SF-12), Patient Health Questionnaire-15 (PHQ-15), and Somatic Symptom Disorder-B Criteria Scale (SSD-12). Patients were divided into high score group (SSD-12≥16, n=56) and low score group (SSD-12>16, n=180). T-test and Mann-Whitney U tests were used to compare the measurement data, and chi-square tests were used to compare the categorical data. Pearson correlation analysis and multiple linear regression was used to analyze the factors affecting the quality of life of SSD. **Results** Compared to the low score group, patients in high score group were more worried about physical discomfort (1.0(0.5, 2.0) h/d *vs.* 3.0(1.0, 8.0) h/d, t=−4.6, P<0.01), less satisfied with the treatment ((3.4±1.4) score *vs.* (2.2±1.8) score, t=4.073, P<0.01), and had lower evaluation to the treatment effect ((3.3±1.4) score *vs.* (2.2±1.5) score, t=4.353, P<0.01). High score patients have a heavier physical and psychological burden and lower quality of life. Pearson correlation analysis showed that quality of life (SF-12) was strongly associated with depression (r=−0.662, P<0.01) and symptom-related cognitive behavior (r=−0.603, P<0.01), and it was weakly associated with somatic symptom severity (r=−0.477, P<0.01). Multiple regression analysis showed that depressive and symptom-related cognitive behaviors had a significant influence on quality of life, which explained 58% of the overall variation (P<0.05). **Conclusion** Depressive level and thoughts, feelings, and behaviors associated to somatic symptoms are important factors affecting the quality of life of SSD patients. Increased attention and timely intervention should be provided to this population.

【**Key words**】 Somatoform Disorders;　Somatic symptom disorder;　Quality of life

躯体症状障碍（somatic symptom disorder，SSD）核心特征是围绕躯体症状的思维、情绪反应及患病行为异常，患者对躯体症状过度关注，常因疲劳、疼痛、心悸、气促、头晕、恶心等各种症状频繁就诊于综合医院的心血管内科、神经内科、消化内科、中医科等临床科室。有研究表明，我国综合医院门诊的SSD检出率高达33.8%[1]。然而，目前针对此类患者的治疗并不满意，患者苦于反复求医、重复检查及治疗，医患双方对就诊的满意程度均较低[2-3]，患者生活质量差[4-5]。针对此类患者，既往研究以DSM-Ⅳ中躯体形式障碍（somatoform disorder，SFD）诊断为主，患者生活质量差且影响因素较多，包括躯体化症状、焦虑抑郁情绪、经济状况、人际关系、社会支持等[6]。对于反复求医的患者，SFD侧重于躯体症状是否可以得到医学解释，而这在临床上操作困难、一致性差，且"症状并非真实存在"可能成为一个心理暗示，并不为饱受躯体困扰的患者所接受。SSD患者可有一个或多个的躯体症状，并对与症状相关的过分的思维、感受或行为进行定义，增加心理症状后该诊断有较好的信效度，其一致性检验*Kappa*值为0.61[7]。相较于SFD，SSD患者检出更高的焦虑和抑郁水平，心理损害更为严

重[8]。Toussaint 等[9-11]基于 DSM-5 中 SSD 诊断的 B 标准研发了躯体症状障碍诊断 B 标准量表（Somatic Symptom Disorder-B Criteria Scale，SSD-12），用于量化评估患者对躯体症状的认知、感受和行为。中文版的 SSD-12 已经通过验证[12]，具有良好的信效度，有助于对 SSD 的识别与干预。本研究我们将 SSD-12 作为重要因变量，探究 SSD 患者的生活质量及其影响因素，以期为临床识别与干预提供依据。

对象和方法

一、对象

采取方便取样法，于 2016 年 5 月至 2018 年 1 月在北京、上海、成都、武汉、晋城的 9 家三级综合医院的门诊连续纳入患者，进行诊断性访谈和问卷测评。选取科室为 SSD 患者就诊频繁的生物医学科室（心血管内科、神经内科、消化内科），以及中医科和心身医学科。

入组标准为：（1）年龄>18 岁；（2）有读写能力、能够配合完成调查；（3）因自身困扰就诊，符合 DSM-5 临床定式检查研究版（Structured Clinical Interview for DSM-5 Research Version，SCID-5-RV）中“躯体症状障碍及疾病焦虑”诊断标准。排除标准：（1）非就医目的来门诊取药或替他人求治；（2）交流困难、语言障碍；（3）认知功能损害、脑器质性障碍、痴呆；（4）重性精神疾病；（5）强烈自杀倾向；（6）长期服用精神活性物质；（7）孕期、哺乳期。

本研究通过中国医学科学院北京协和医院伦理委员会审批（伦理批号：S-K276），所有受试者均知情同意并签署了知情同意书。

二、方法

本研究为多中心横断面研究，以问卷和访谈形式收集患者基本资料以及临床信息，量表填写时间约为 30 min。

1. 一般情况：采用自编问卷，收集一般人口学资料、生活方式及就诊行为，如果受访患者在过去 6 个月接受过药物和（或）心理治疗，则请患者对治疗的满意度和效果分别按 0~5 分进行评分，分值越高，治疗满意度越高、主观治疗效果越好。

2. 量表测评：（1）12 项健康调查简表（12-item medical outcomes study short form health survey，SF-12）用于评价患者过去 4 周内健康相关生活质量，分为精神健康总评（mental component summary，MCS）和躯体健康总评（physical component summary，PCS）2 部分，总分均为 0~100 分，分值越高生命质量越佳。中文版 SF-12 在一般人群验证性研究显示信效度良好，MCS 和 PCS 标准平均值分别为 48.4 分和 50.2 分[13]。（2）SSD-12：用于量化评估患者对躯体症状的认知、感受和行为，总分值为 0~48 分，分值越高提示患者对躯体症状的反应程度越严重，以总分≥16 分为界值，心理测量学评价显示信效度良好[12]。（3）健康焦虑量表（Whiteley-8 Scale，WI-8）：用于评估患者过去 4 周患病信念和健康担忧，总分为 8~40 分，分值越高提示健康焦虑越严重[14]。（4）患者健康问卷抑郁症状群量表（Patient Health Questionnare-9，PHQ-9）：用于评估患者过去 2 周抑郁症状严重程度，总分 0~27 分，分值越高表示抑郁程度越严重；中文版 PHQ-9 在综合医院门诊的使用中具有良好的信效度[15]。（5）广泛性焦虑量表（General Anxiety Disorder，GAD-7）：用于评估患者过去 2 周的焦虑症状严重程度，总分值为 0~21 分，分值越高提示 焦虑程度越严重；中文版 GAD-7 具有良好的信效度[16]。（6）患者健康问卷躯体症状群量表（Patient Health Questionnaire-15，PHQ-15）：用于量化患者过去 4 周躯体症状的数量和严重程度，总分 0~30 分，分值越高症状越严重，中文版具有良好的信效度[17]。（7）世界卫生组织残疾评定方案 2.0（WHO Disability Assessment Schedule 2.0，WHO DAS 2.0）：用于量化评价患者完成日常生活任务的功能受损程度，总分 0~100 分，分值越高表示残疾程度越严重[18]。

3. 诊断性访谈：购买英文原版 SCID-5-RV 中“躯体症状障碍及疾病焦虑”章节，请国内 3 名精通英语的精神科医生及医学生、1 名母语为英语的心身医学专家经两轮翻译、回译，并进行试验性研究，最终诊断性访谈中文版用于 SSD 诊断并评估严重程度。

4. 研究流程：研究者对签署知情同意书的受试者进行问卷调查及诊断性访谈。所有研究者在调查之前由富有经验的精神科副主任及以上的医师进行培训，使用统一指导语。根据 SSD-12 评分分为高分组（SSD-12≥16 分）和低分组（SSD-12>16 分）。

5. 统计学处理：录入量表和访谈数据，采用 SPSS 24.0 软件进行统计学分析。符合正态分布的计量资料以 $\bar{x} \pm s$ 表示，组间比较采用 t 检验，不符合正态分布的计量资料以中位数（四分位数）[M（P_{25}，P_{75}）]表示，组间比较采用 Mann-Whitney U 检

验；计数资料以频数和百分比表示，组间比较采用χ^2检验；采用Pearson相关、多重线性回归分析SSD生活质量的影响因素。检验水准为α=0.05。

结　果

一、一般人口学资料

共236例患者纳入研究，其中男93例（39.4%）、女143例（60.0%），年龄（43.0±14.0）岁，低分组共56例（23.4%）、高分组共180例（76.3%）。相较于高分组，低分组患者已婚居多、锻炼时间较长，其余社会人口学信息2组间差异无统计学意义；见表1。

表1　SSD-12评分低分组与高分组一般人口学资料比较[例(%)]

项目	低分组（n=56）	高分组（n=180）	t/χ^2值	P值
年龄（岁，$\bar{x}\pm s$）	45.5±13.4	42.2±14.2	1.513	0.132
女性	31(55.5)	112(62.2)	0.843	0.359
汉族	49(87.5)	170(94.4)	3.081	0.079
已婚	45(80.4)	118(65.6)	4.380	0.036
城市居住者	46(82.1)	141(78.8)	0.298	0.585
与家人生活	53(94.6)	163(90.6)	0.920	0.337
高中及以上学历	39(69.6)	124(68.9)	0.011	0.915
在职	22(39.3)	83(46.1)	0.806	0.369
月收入8 000元以上	17(30.4)	48(27.0)	0.244	0.621
目前正在吸烟	9(16.1)	30(16.8)	0.015	0.904
每日饮酒	1(1.8)	5(2.8)	0.174	0.677
冬季不规律锻炼（<2 h/周）	44(78.6)	145(80.6)	5.842	0.120
夏季不规律锻炼（<2 h/周）	41(73.2)	140(77.8)	2.934	0.402
BMI（kg/m^2，$\bar{x}\pm s$）	23.0±4.1	22.1±3.8	1.549	0.123
有医保	49(87.5)	151(84.8)	0.244	0.621

注：SSD-12为躯体症状障碍诊断B标准量表；BMI为身体质量指数

二、就医行为

SSD患者多选择生物医学科以及心身医学科进行诊治。与低分组相比，高分组担忧躯体不适的时间更长，平均4.5 h/d，治疗满意度及主观治疗效果更低，过去12个月的就诊次数更多；见表2。

表2　SSD-12评分低分组与高分组就医行为分析[例(%)]

项目	低分组（n=56）	高分组（n=180）	$t/\chi^2/Z$值	P值
担忧躯体不适时间［h/d，$M(P_{25},P_{75})$］	1.0(0.5,2.0)	3.0(1.0,8.0)	−5.928	<0.01
过去12个月就诊次数			5.388	0.020
0~2次	22(39.3)	42(23.5)		
>2次	34(60.7)	137(76.5)		
就诊科室			3.173	0.205
生物医学科	27(48.2)	63(35.0)		
中医科	9(16.1)	35(19.4)		
心身医学科	20(35.7)	82(45.6)		
治疗满意度（分，$\bar{x}\pm s$）	3.4±1.4	2.2±1.8	4.073	<0.01
主观治疗效果（分，$\bar{x}\pm s$）	3.3±1.4	2.2±1.5	4.353	<0.01

注：SSD-12为躯体症状障碍诊断B标准量表；$M(P_{25},P_{75})$为中位数（四分位数）

三、量表评估

SSD患者的SF-12平均得分为74分。与低分组比较，高分组SF-12得分低，PHQ-15、WHO-DAS、SSD-12、WI-8、PHQ-9、GAD-7得分较高，以及SSD严重程度较高，2组比较差异均有统计学意义（均P<0.01）；见表3。

表3　SSD-12评分低分组与高分组量表评分比较（分，$\bar{x}\pm s$）

项目	低分组（n=56）	高分组（n=180）	t/χ^2值	P值
PHQ-15	8.6±4.0	13.1±5.5	−6.629	<0.01
WHO-DAS	17.3±4.8	24.3±8.7	−7.685	<0.01
SSD-12	8.3±4.2	28.4±8.3	−24.094	<0.01
WI-8	16.0±4.9	27.0±7.5	−12.780	<0.01
PHQ-9	6.3±4.4	13.6±6.4	−9.649	<0.01
GAD-7	5.4±4.6	11.0±5.9	−7.418	<0.01
SF-12	89.6±12.3	69.2±13.1	10.233	<0.01
SSD严重程度[例(%)]			13.401	0.01
轻	20(37.7)	26(15.2)		
中	17(32.1)	61(35.7)		
重	16(30.2)	84(49.1)		

注：PHQ-15为患者健康问卷躯体症状群量表；WHO-DAS为世界卫生组织残疾评定方案2.0；SSD-12为躯体症状障碍诊断B标准量表；WI-8为健康焦虑量表；PHQ-9为患者健康问卷抑郁症状群量表；GAD-7为广泛性焦虑量表；SF-12为12项健康调查简表；SSD为躯体症状障碍

Pearson相关分析显示，健康相关生活质量与抑郁症状严重程度（r=−0.662，P<0.01）、症状相关的认知行为（r=−0.603，P<0.01）呈强相关，与躯体症状数量和严重程度（r=−0.477，P<0.01）呈弱相关；见表4。

四、相关与回归分析

SF-12评分与一般人口学资料及就诊行为等变量的相关分析显示，就诊科室（r=−0.211，P=0.010）、性别（r=−0.153，P=0.019）、婚姻状况（r=−0.164，P=0.012）、冬季和夏季不规律体育锻炼（r=−0.187、−0.174，P=0.004、0.008）、治疗满意度（r=0.308，P<0.01）、主观治疗效果（r=0.335，P<0.01）、担忧躯体不适时间（r=−0.327，P<0.01）与生活质量

表 4　SSD 患者（n=236）生活质量评估得分与其他量表得分的相关分析（r 值）

量表	SF-12	PHQ-15	WHO-DAS	SSD-12	WI-8	PHQ-9	GAD-7
SF-12	1	−0.477[a]	−0.582[a]	−0.603[a]	−0.563[a]	−0.662[a]	−0.581[a]
PHQ-15	–	1	0.478[a]	0.383[a]	0.432[a]	0.531[a]	0.447[a]
WHO-DAS	–	–	1	0.459[a]	0.475[a]	0.642[a]	0.494[a]
SSD-12	–	–	–	1	0.767[a]	0.519[a]	0.525[a]
WI-8	–	–	–	–	1	0.628[a]	0.653[a]
PHQ-9	–	–	–	–	–	1	0.758[a]
GAD-7	–	–	–	–	–	–	1

注：SSD 为躯体症状障碍；SF-12 为 12 项健康调查简表；PHQ-15 为患者健康问卷躯体症状群量表；WHO-DAS 为世界卫生组织残疾评定方案 2.0；SSD-12 为躯体症状障碍诊断 B 标准量表；WI-8 为健康焦虑量表；PHQ-9 为患者健康问卷抑郁症状群量表；GAD-7 为广泛性焦虑量表；[a]P<0.01；–为无相关数据

显著相关，而年龄、居住环境、受教育程度、家庭月收入、职业状况、吸烟和饮酒等生活习惯与生活质量均不相关（r=−0.086~0.002，均 P>0.05）。

以 SF-12 总分为因变量，在相关分析中有统计学意义的一般人口学资料、就医行为及量表评分作为自变量逐步进入回归方程，结果显示，抑郁症状严重程度、与症状相关的认知行为对 SSD 患者的生活质量有显著影响，可解释生活质量 61.7% 的变异（调整后 R^2=0.580）；见表 5。

表 5　SSD 患者生活质量影响因素的多重线性回归分析

变量	β 值	SE 值	标化系数	P 值
截距	103.829	5.604	–	–
PHQ-9	−0.590	0.221	−0.256[a]	0.01
SSD-12	−0.477	0.110	−0.345[a]	<0.01

注：SSD 为躯体症状障碍；PHQ-9 为患者健康问卷抑郁症状群量表；SSD-12 为躯体症状障碍诊断 B 标准量表；[a]P<0.05；–为无相关数据

讨　论

与 DSM-Ⅳ中的 SFD 相比，SSD 中不再强调“医学上无法解释的”症状，而是认可患者可有 1 个或多个的躯体症状，并对与症状相关的异常和过度的思想、情感和行为进行了定义。在临床应用中，大量的 SSD 患者首诊于综合医院的临床各科以及基层医疗保健机构，B 标准的评估对于非精神专科医师极具挑战性[4]。SSD-12 是为 SSD 诊断 B 标准研发的量表，有助于识别 SSD 患者[11]。本研究显示，76.2%（180 例）的 SSD 患者 SSD-12 得分≥16 分，其过度担忧躯体症状、反复就诊等不良患病行为显著增加，躯体负担、心理反应均较为严重，生活质量明显下降。

SSD 患者生活质量的预测因素包括 PHQ-9、SSD-12，而 PHQ-15 未进入回归方程，提示躯体症状的严重程度并不是影响 SSD 患者生活质量的主要因素，而与症状相关的不良的思维、感受、行为等严重损害其生活质量。相较于躯体症状严重程度，与症状相关的负性心理反应更能预测生活质量[5]。Escobar 等[19]通过对社区样本的研究提示，躯体症状并不直接影响 SSD 患者的生活质量。他们发现，无论躯体症状能否被解释，3 个及 3 个以上的躯体症状是抑郁、焦虑等精神疾患的重要预测因子，与功能残疾和低生活质量相关。“医学无法解释的症状”和“医学可以解释的症状”对疾病预后并无显著影响[20]，而疾病感知、归因对个体的躯体感觉和症状反应起决定性的作用[21]。以消化道症状为例的研究提示，与单纯躯体疾病患者相比，功能性疾病患者的不适主诉更多、生活质量更差[22]。此外，对 SFD 患者的研究显示，生活质量差与精神心理因素显著相关[23]。患者对症状的负性认知、情绪反应及不良的患病行为与生活质量密切相关[24-26]。这提示心理因素，尤其对躯体症状的认知、感受和行为，是 SSD 患者生活质量受损的重要影响因素。该结果为整合的心身治疗提供了重要的依据。医患双方仅聚焦于躯体症状的改善无法取得满意的疗效；心身合一的干预有助于改善患者的情绪体验、疾病认知及异常患病行为，提高生活质量[27]。

躯体症状是一种应激，多数患者及其家庭能够逐渐接受和适应，并进行有分寸的求助，而 SSD 患者则相反，其主要表现为围绕躯体症状的思维、情绪反应及患病行为的异常，如对症状严重程度的想法与实际情况不相称、持续高水平地焦虑、投入过多的时间和精力[7]。因此，SSD 患者的躯体症状是打开其心门的钥匙，通过建立充分信任的治疗关系，在心理感受和心理加工层面深入探讨躯体症状、患病行为背后的推动力，调动患者的主动性和行动力，处理患病过程中“灾难化”“以偏概全”等导致不良应对的认知模式，觉察症状背后的心理意义，用积极的行动，改善不良应对方式，从而提升生活质量[7]。

本研究采用 SCID-5-RV 作为诊断标准，在全国 5 个城市的 9 家三甲综合医院门诊完成 SSD 患者的诊断筛查，并探究 SSD 患者生活质量及其影响因素，结果具有较好的代表性和推广性。但受限于横

断面研究，无法判断SSD患者负性情绪、认知及异常患病行为与生活质量的因果关系；作为初步探索，本研究中选取了SSD患者较常就诊的科室，可能存在偏倚。在未来，可以进一步扩大目标科室，开展纵向队列研究，更全面地了解SSD患者的临床及功能状态。本研究显示抑郁症状严重程度及对躯体症状的认知、感受和行为是SSD患者生活质量受损的重要影响因素。综合医院诊疗过程中，应重视SSD患者的心理反应，关注患者的情绪体验、疾病认知及异常患病行为，及时进行心身合一的干预，有助于提升患者的生活质量。

利益冲突　所有作者均声明不存在利益冲突

参 考 文 献

[1] 姜忆南, 魏镜, 李涛, 等. 躯体形式障碍与躯体症状障碍患者临床特征比较[J]. 中华精神科杂志, 2020, 53(1): 29-34. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1006-7884.2020.01.006.
Jiang Yinan, Wei Jing, Li Tao, et al. Comparison of clinical features: somatoform disorder and somatic symptom disorder[J]. Chin J Psychiatry, 2020, 53(1): 29-34. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1006-7884.2020.01.006.

[2] 熊娜娜, 洪霞, 蒋静, 等. 综合医院门诊多躯体症状患者的躯体疾病和精神心理特点[J]. 协和医学杂志, 2014, 5(2): 129-134.DOI:10.3969/j.issn.1674-9081.2014.02.001.
XIONG Na-na, HONG Xia, JIANG Jing, et al. Physical illnesses and psychological characteristics of outpatients with multiple somatic symptoms in a general hospital[J].Medical Journal of Peking Union Medical College Hospital, 2014, 5(2):129-134.DOI:10.3969/j.issn.1674-9081.2014.02.001.

[3] 刘辰. 多躯体症状患者的心理及行为特点[D]. 北京:北京协和医学院, 2013.

[4] 魏镜, 李涛, 罗夏红. 躯体症状障碍诊断标准及可操作性研究现状[J]. 中华精神科杂志, 2019, 52(4): 235-240. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1006-7884.2019.04.001.
Wei Jing, Li Tao, Luo Xiahong. Current status of research on diagnostic criteria and its operationalization of somatic symptom disorder[J]. Chin J Psychiatry, 2019, 52(4): 235-240. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1006-7884. 2019.04.001.

[5] 崔飞环. 躯体症状障碍患者的心理行为特征[D]. 北京:北京协和医学院, 2017.

[6] 吴琼. 躯体形式障碍患者生活质量及相关因素研究[D]. 长春:吉林大学,2013.

[7] 陆林. 沈渔邨精神病学[M]. 北京:人民卫生出版社,2018.

[8] Hüsing P, Löwe B, Toussaint A. Comparing the diagnostic concepts of ICD-10 somatoform disorders and DSM-5 somatic symptom disorders in patients from a psychosomatic outpatient clinic[J]. J Psychosom Res, 2018, 113:74-80. DOI: 10.1016/j.jpsychores.2018.08.001.

[9] Toussaint A, Murray AM, Voigt K, et al. Development and Validation of the Somatic Symptom Disorder-B Criteria Scale (SSD-12) [J]. Psychosom Med, 2016, 78(1): 5-12. DOI: 10.1097/PSY.0000000000000240.

[10] Toussaint A, Löwe B, Brähler E, et al. The Somatic Symptom Disorder-B Criteria Scale (SSD-12): factorial structure, validity and population-based norms[J]. J Psychosom Res, 2017, 97: 9-17. DOI: 10.1016/j.jpsychores.2017.03.017.

[11] Toussaint A, Riedl B, Kehrer S, et al. Validity of the Somatic Symptom Disorder-B Criteria Scale (SSD-12) in primary care[J]. Fam Pract, 2018, 35(3): 342-347. DOI: 10.1093/fampra/cmx116.

[12] Li T, Wei J, Fritzsche K, et al. Validation of the Chinese Version of the Somatic Symptom Disorder-B Criteria Scale for detecting DSM-5 somatic symptom disorders: a multicenter study[J]. Psychosom Med, 2020, 82(3): 337-344. DOI: 10.1097/PSY.0000000000000786.

[13] Lam CL, Tse EY, Gandek B. Is the standard SF-12 health survey valid and equivalent for a Chinese population?[J]. Qual Life Res, 2005, 14(2): 539-547. DOI: 10.1007/s11136-004-0704-3.

[14] Welch PG, Carleton RN, Asmundson GJ. Measuring health anxiety: moving past the dichotomous response option of the original Whiteley Index[J]. J Anxiety Disord, 2009, 23(7):1002-1007. DOI: 10.1016/j.janxdis.2009.05.006.

[15] 陈然, 王瑜, 余建英, 等. PHQ-9在综合医院住院患者中信效度研究[J]. 四川精神卫生, 2017, 30(2): 149-153. DOI: 10.11886/j.issn.1007-3256.2017.02.013.
Chen Ran, Wang Yu, Yu Jianying, et al. Evaluation of the reliability and validity of PHQ-9 in general hospital inpatients[J]. Sichuan Mental Health, 2017, 30(2): 149-153. DOI: 10.11886/j.issn.1007-3256.2017.02.013.

[16] 何筱衍,李春波,钱洁,等. 广泛性焦虑量表在综合性医院的信度和效度研究[J]. 上海精神医学,2010,22(4):200-203. DOI:10.3969/j.issn.1002-0829.2010.04.002.
He Xiaoyan, Li Chunbo, Qian Jie, et al. Reliability and validity of a generalized anxiety disorder scale in general hospital outpatients[J].2010,22(4):200-203.DOI:10.3969/j.issn.1002-0829.2010.04.002.

[17] Zhang L, Fritzsche K, Liu Y, et al. Validation of the Chinese version of the PHQ-15 in a tertiary hospital. BMC Psychiatry[J]. 2016, 16: 89. DOI: 10.1186/s12888-016-0798-5.

[18] 王莲娥, 周洁, 金欢. 世界卫生组织残疾评定量表第2版中文版在精神残疾评定中的信效度检验[J]. 中国心理卫生杂志, 2013, 27(2):121-125. DOI: 10.3969/j.issn.1000-6729. 2013.02.008.
WANG Lian-E, ZHOU Jie, JIN Huan. Reliability and validity of the Chinese version of WHO Disability Assessment Schedule 2.0 in mental disability assessment[J]. Chin J Psychiatry, 2013, 27(2): 121-125. DOI: 10.3969/j. issn. 1000-6729.2013.02.008.

[19] Escobar JI, Cook B, Chen CN, et al. Whether medically unexplained or not, three or more concurrent somatic symptoms predict psychopathology and service use in community populations[J]. J Psychosom Res, 2010, 69(1): 1-8. DOI: 10.1016/j.jpsychores.2010.01.001.

[20] Klaus K, Rief W, Brähler E, et al. The distinction between "medically unexplained" and "medically explained" in the context of somatoform disorders[J]. Int J Behav Med, 2013, 20(2):161-171. DOI: 10.1007/s12529-012-9245-2.

[21] Rief W, Nanke A, Emmerich J, et al. Causal illness attributions in somatoform disorders: associations with comorbidity and illness behavior[J]. J Psychosom Res, 2004, 57(4): 367-371. DOI: 10.1016/j. jpsychores. 2004. 02.015.

[22] Nakao H, Konishi H, Mitsufuji S, et al. Comparison of

clinical features and patient background in functional dyspepsia and peptic ulcer[J]. Dig Dis Sci, 2007, 52(9): 2152-2158. DOI: 10.1007/s10620-006-9204-3.

[23] 马希权, 张岚, 张耀尹, 等. 综合医院门诊躯体形式障碍患者功能损害及相关影响因素[J]. 中华精神科杂志, 2019, 52(4): 241-246. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1006-7884. 2019.04.002.
Ma Xiquan, Zhang Lan, Zhang Yaoyin, et al. Evaluation of the associated feature with mental disability in outpatients with somatoform disorders in general hospital[J]. Chin J Psychiatry, 2019, 52(4): 241-246. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1006-7884.2019.04.002.

[24] Rief W, Mewes R, Martin A, et al. Are psychological features useful in classifying patients with somatic symptoms? Psychosom Med, 2010, 72(7): 648-655. DOI: 10.1097/PSY.0b013e3181d73fce.

[25] Rief W, Mewes R, Martin A, et al. Evaluating new proposals for the psychiatric classification of patients with multiple somatic symptoms[J]. Psychosom Med, 2011, 73(9): 760-768. DOI: 10.1097/PSY. 0b013e318234eff6.

[26] Wu H, Zhao X, Fritzsche K, et al. Negative illness perceptions associated with low mental and physical health status in general hospital outpatients in China[J]. Psychol Health Med, 2014, 19(3):273-285. DOI: 10.1080/13548506.2013.802358.

[27] 赵晓晖, 魏镜, 李涛, 等. 躯体症状障碍患者临床特征分析[J]. 中华精神科杂志, 2019, 52(4):247-252. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1006-7884.2019.04.003.
Zhao Xiaohui, Wei Jing, Li Tao, et al. Clinical characters of the patients with somatic symptom disorder[J]. Chin J Psychiatry, 2019, 52(4): 247-252. DOI: 10.3760/cma. j. issn.1006-7884.2019.04.003.

·读者·作者·编者·

本刊可直接使用的医学缩写词

在本刊发表的论文中，应尽量不使用或少使用缩写词，而精神医学专业领域公知公认的缩写词（表 1）可以不加注释直接使用，本刊论文中将不再注释。不超过 4 个汉字的名词不宜用缩写词。

表 1　《中华精神科杂志》可直接使用的缩写词

缩写词	中文全称	缩写词	中文全称
5-HT	5-羟色胺	MDQ	心境障碍问卷
95%*CI*	95% 可信区间	MMSE	简明精神状态检查
BA	布罗德曼分区	MCI	轻度认知功能障碍
CGI	临床疗效总评量表	MRI	磁共振成像
CCMD-3	中国精神障碍分类诊断标准第三版	MNI	蒙特利尔神经科学研究所
CT	电子计算机体层扫描	MoCA	蒙特利尔认知评估量表
DBS	深部脑刺激治疗	NaSSA	去甲肾上腺素能与特异性 5-羟色胺能抗抑郁药
DSM-Ⅲ	美国精神障碍诊断与统计手册第 3 版	NE	去甲肾上腺素
DSM-Ⅳ	美国精神障碍诊断与统计手册第 4 版	PANSS	阳性和阴性症状量表
DSM-Ⅳ-TR	美国精神障碍诊断与统计手册第 4 版修订版	PCR	聚合酶链反应
DSM-5	美国精神障碍诊断与统计手册第 5 版	PTSD	创伤后应激障碍
DTI	弥散张量成像	PET	正电子发射断层显像术
ELISA	酶联免疫吸附测定	RT-PCR	逆转录-聚合酶链反应
ECT	电休克治疗	rTMS	重复经颅磁刺激
FDA	美国食品药品监督管理局	SPECT	单光子发射计算机断层显像
fMRI	功能磁共振成像	SSRIs	选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂
HAMD	汉密尔顿抑郁量表	SNRIs	5-羟色胺和去甲肾上腺素再摄取双重抑制剂
HAMA	汉密尔顿焦虑量表	SCID-Ⅰ	DSM-Ⅳ-TR 轴Ⅰ障碍用临床定式检查
HCL-32	32 项轻躁狂症状自评量表	SCID-Ⅰ/P	DSM-Ⅳ-TR 轴Ⅰ障碍用临床定式检查患者版
HPA	下丘脑-垂体-肾上腺	TNF	肿瘤坏死因子
ICD-10	国际疾病分类第 10 版	TCAs	三环类抗抑郁药
ICD-11	国际疾病分类第 11 版	WHO	世界卫生组织
IL	白细胞介素	WCST	威斯康星卡片分类测验
MECT	改良电休克治疗	Y-BOCS	耶鲁布朗强迫症状量表
MINI	简明国际神经精神访谈		

中华精神科杂志编辑部